

**KERANGKA ACUAN PROGRAM
STRATEGI PENGUATAN JEJARING
SITI FATIMAH FAST RESPON TEAM
(Si-FAST)
RSU AISYIYAH SITI FATIMAH
TAHUN 2025**



NAMA PELAPOR	: KURNIAWAN,S.Kep.,Ns
UNIT KERJA	: KOMITE MUTU
NIK	: 51.01.07.2011
TGL	: 09 Juli 2025
JUMLAH HALAMAN	: 15

**RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH SITI FATIMAH
JL. Raya Kenongo No.14 Tulangan Sidoarjo
Telp. (031) 8856303, 8851840
Fax. (031) 8851922
Email. aisyiyah.15@gmail.com**

KERANGKA ACUAN PROGRAM
PEMBENTUKAN
COMMAND CENTER/ *Siti Fatimah Fast Response Team* (SIFAST)
RUMAH SAKIT AISYIYAH SITI FATIMAH

BAB 1 Pendahuluan

Penanganan yang baik di saat terjadinya kecelakaan baik kecelakaan di jalan raya, kecelakaan di tempat kerja maupun trauma akibat bencana alam diharapkan mampu menurunkan resiko komplikasi, kecacatan dan kematian pada korban. Oleh sebab itu kehadiran para medis yang tergabung di dalam trauma center dalam menangani kasus kasus kecelakaan juga bencana alam menjadi kunci keselamatan korban.

Tenaga media maupun non medis harus paham benar tentang apa yang terjadi pada korban kecelakaan maupun bencana alam sehingga mampu memberikan bantuan dan tindakan yang spesifik.

Ada banyak kasus kecelakaan maupun bencana serta kerusakan yang di bawah ke RS dengan tidak mendapat penanganan pre hospital yang tepat yang mengakibatkan korban cacat bahkan meninggal dunia. Untuk memberikan penanganan yang baik terhadap korban kecelakaan, korban bencana dan kerusakan di pandang perlu untuk meningkatkan rumah sakit menjadi trauma center yang di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik, terutama rumah sakit yang letaknya berada di jalan raya. RSUD Aisyiyah Siti Fatimah menjadi RS Trauma Center di Tulangan Sidoarjo mengingat lokasinya yang strategis di pusat kecamatan Tulangan dan juga berada persis di jalan raya yang ramai dengan mobilitas transportasi. Agar Trauma Center di RSUD Aisyiyah Siti Fatimah dapat berfungsi dengan baik nantinya masing – masing pemerintah daerah yang ada perlu membangun system SiFast (*Siti Fatimah Fast Response Team*) pelayanan medis yang baik dan terkoneksi dan terkoordinasi dengan RS ada. Sebagai sarana penghubung dengan Masyarakat di wilayah tulangan dan sekitarnya dengan menggunakan akses cepat dengan mendirikan command center maka informasi dapat diperoleh melalui media atau sarana website yang sudah terkoneksi dengan Call Center RS, sehingga setiap kecelakaan yang di laporkan oleh masyarakat akan mendapat respon pelayanan yang cepat dengan fasilitas yang memandai dari petugas Ambulance dan Trauma Center RS.

Dengan menerima laporan melalui Call Center maka pasien/korban kecelakaan, bencana alam maupun korban kerusakan dapat segera di tangani dan di bawa ke RSUD Aisyiyah Siti fatimah agar segera mendapat pertolongan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat di berikan dan di desain agar tidak saja tanggap terhadap kejadian trauma pre Hospital namun mampu memberikan pelayanan selama korban berada di RS sampai ke tahap pemulihan pasien pulang kontrol di rumah.

Untuk mendukung terbentuknya SiFast (*Siti Fatimah Fast Response Team*) RSUD Aisyiyah Siti Fatimah maka sangat di butuhkan IGD yang terintegrasi dengan pelayanan Trauma Center dimana IGD dan Pusat Pelayanan Trauma Center di lengkapi dengan

sarana dan prasarana pendukung dan juga tenaga yang siap pakai yang sudah di bekali dengan ilmu dan ketrampilan di dalam menangani korban gawat darurat.

Tujuan :

1. Didapatkan kesamaan pola pikir / persepsi tentang SPGDT dan call center Rumah Sakit.
 2. Diperoleh kesamaan pola pikir, pola tindak dalam penanganan kasus gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun bencana pada trauma center Rumah Sakit.
- Ruang Lingkup

Ruang lingkup

KAK ini yaitu panduan bagi RSU Aisyiyah Siti Fatimah dalam melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan *Siti Fatimah Fast Response Team* di unit masing – masing.

BAB II
Siti Fatimah Fast Response Team (Si-FAST)/ Commad Center
PUSAT PELAYANAN INFORMASI TERPADU

Adalah sebagai alat komunikasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agar tidak ada jarak bagi Masyarakat yang mengalami masalah Kesehatan. dimanapun mereka berada yang melibatkan peran aktif seluruh staf dan profesi maupun masyarakat (misal : PSC, Poskesdes, relawan, tokoh Masyarakat dan champion As-pri dll).

A. Aspek *Command Centre* :

1. *Care* :

Kerja-sama lintas sektoral bidang kesehatan dalam menata perilaku dan lingkungan untuk mempersiapkan, mencegah dan melakukan mitigasi dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan.

2. *Cure* :

Peran utama sektor kesehatan dibantu sektor terkait dalam penanganan keadaan dan kasus-kasus gawat-darurat.

B. Visi *Command Centre*:

1. Menjadi sarana yang mampu melindungi masyarakat dalam keadaan darurat sehari-hari dan bencana, maupun atas dampak akibat terjadinya bencana.
2. Terciptanya perilaku masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan situasi sehat dan aman.

C. Misi *Command Centre* :

1. Menciptakan gerakan di masyarakat
2. Mendorong kerja-sama lintas sektor-program
3. Mengembangkan standar nasional
4. Mengusahakan dukungan dana dalam rangka pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama dalam keadaan darurat.
5. Menata sistem pendukung pelayanan diseluruh unit pelayanan RS

D. Nilai dasar *Command Centre* :

1. ***Care*** : pencegahan, penyiagaan dan mitigasi
2. ***Equity*** : adanya kebersamaan dari institusi swasta, pemerintah, kelompok/organisasi profesi dan masyarakat
3. ***Partnership*** : menggalang kerja-sama lintas sektor dan masyarakat untuk mencapai tujuan

4. **Net working** : membangun jaring kerja-sama dalam suatu sistem dengan melibatkan seluruh potensi yang terlibat
5. **Sharing** : memiliki rasa saling membutuhkan dan kebersamaan dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sehari – hari.

E. Maksud Usaha Command Centre :

Memberikan pedoman baku bagi instalasi/ unit terkait dalam melaksanakan pelayanan dan kegiatan hubungan dengan atau antar departemen bahkan pihak lain di luar institusi agar tercipta masyarakat sehat, aman dan Sejahtera.

a. Tujuan Usaha Command Centre:

1. Partisipasi masyarakat mendorong perilaku peduli SPGDT yang dapat diterapkan.
2. Membangun respons masyarakat melalui pusat pelayanan terpadu dan potensi penyiagaan fasilitas.
3. Mempercepat response time untuk menghindari kematian dan kecacatan.

b. Sasaran Usaha Command Centre :

1. Tingkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian dalam kewaspadaan dini kegawat-daruratan.
2. Terlaksananya koordinasi lintas sektor terkait, tergabung dalam satu kesatuan.
3. Terwujudnya subsistem komunikasi dan transportasi sebagai pendukung.

c. Falsafah dan Tujuan Command Centre :

1. Memberikan rasa sehat dan aman dengan melibatkan seluruh potensi, memanfaatkan
2. kan kemampuan - fasilitas secara optimal.
3. Merubah perilaku agar mampu menanggulangi kegawat-daruratan sehari-hari.
4. Ada visi, misi, tujuan dan sasaran.
5. Motto 'time saving is life and limb saving' dan kemampuan rehabilitasi.

d. Ketentuan organisasi :

1. Didasarkan pada organisasi yang melibatkan multi disiplin dan multi profesi.
2. Memiliki unsur Pimpinan/wakil, sekretaris, bendahara dan anggota.
3. Minimal melibatkan unsur kamtib & SAR. Kemudian unsur keselamatan & kesehatan kerja karyawan dan humas.

e. Administrasi-Pengelolaan :

1. Ada struktur, uraian tugas, kewenangan dan mekanisme kerja dengan unit lain.

2. Ada unit kerja terkait.
3. Ada produk hukum : dasar.
4. Ada petunjuk dan informasi untuk jamin kemudahan dan kelancaran dalam mem
1. berikan pelayanan di masyarakat.
5. Ada PSC sebagai unit respons cepat.

f. Pengorganisasian :

1. Command Centre diselenggarakan oleh seluruh komponen, kepala bidang menetapkan organisasi ini dengan SK.
2. Organisasi dimaksud adalah *Command Centre* yang dibangun di RS.
3. Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang ditetapkan sesuai kebutuhan yang harus online 24 jam untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

g. Fasilitas - Peralatan :

1. Fasilitas harus dapat menjamin efektifitas pelayanan termasuk pelayanan IGD di RS 24 jam.
2. Sarana dan prasarana, peralatan dan obat sesuai dengan standard
3. Adanya subsistem pendukung baik komunikasi, transportasi termasuk ambulance dan keselamatan kerja.

h. Kebijakan & prosedur :

1. Tertulis agar dapat dievaluasi dan disempurnakan.
2. Ditetapkan kebijakan pelayanan kasus gadar pra RS, RS dan rujukan, termasuk Hospital disaster plan
3. Ditetapkan ada SPGDT dan perhatikan keselamatan kerja dan Kegawatdaruratan sehari-hari.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI TAMBAHAN

A. SPGDT :

Sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur pra RS, RS dan antar RS. Berpedoman pada respon cepat yang menekankan *time saving is life and limb saving*, yang melibatkan masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan RS penjemputan ambulans gawat darurat dan komunikasi/konsultasi medis dll.

PSC (Public Safety Center) :

Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat dan dimanapun berada (gabungan dari PSC 119, SAR/PK 113, Polisi 110). Merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk mendapatkan respons cepat (*quick response*) terutama pelayanan pra RS.

B. SUB SISTEM SPGDT

a. Sistem Pra RS Sehari -hari

1. Poskesdes didirikan pemerintahan desa. Sebagai unit khusus pra RS. Pengorganisasian di jajaran kesehatan.
2. Pelayanan Ambulans. Koordinasi dengan memanfaatkan ambulans setempat.
3. Komunikasi. Koordinasi jejaring informasi.
4. Pembinaan. Pelatihan peningkatan kemampuan.

b. Sistem Pra RS pada bencana

1. Koordinasi jadi komando. Efektif dan efisien bila dalam koordinasi dan komando
2. Eskalasi dan mobilisasi sumber daya. SDM, fasilitas dan sumber daya lain.
3. Simulasi. Diperlukan protap, juklak, juknis yang perlu diuji melalui simulasi.
4. Pelaporan, monitoring, evaluasi. Laporan dengan sistematika yang disepakati.

c. Fase Acute Response

1. Acute emergency response.
Melaksanakan Rescue, triase, resusitasi, stabilisasi, diagnosis, terapi definitif.
2. Emergency relief.

Menyediakan makanan minuman, tenda, jamban dll. untuk korban 'sehat'.

3. Emergency rehabilitation.

Perbaikan jalan, jembatan, sarana dasar lain untuk kelancaran pertolongan.

C. SPGDT INTRA RS

1. Codeblue system
2. Sarana, prasarana, IGD, *HCU*, *ICU*, penunjang
3. Hospital Disaster Plan, bencana dari dalam dan luar RS.
4. Transport intra RS.
5. Pelatihan, simulasi dan koordinasi untuk peningkatan kemampuan SDM.
6. Pembiayaan dengan jumlah cukup.

D. SOP Minimal RS :

Sehari-hari dan Bencana (Hosdip, Hospital Disaster Plan) :

1. Kegawatan dengan ancaman kematian
2. True emergency
3. Korban massal
4. Keracunan massal
5. Khusus :
 - a) Perkosaan, KDRT, child abused
 - b) Persalinan Tidak Normal
 - c) Kegawatan diruang rawat
6. Ketentuan :
 - a) Asuransi
 - b) Batasan tindakan medik
 - c) Etika & Hukum
 - d) Pendataan
 - e) Tanggung jawab dokter pada keadaan gawat darurat

E. SPGDT ANTAR RS

1. Jejaring berdasar kemampuan RS dalam kualitas dan kuantitas.
2. Evakuasi. Antar RS dan dari pra RS .
3. Manajemen Sistem Informasi Untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dalam pelayanan.
4. Koordinasi dalam pelayanan rujukan, diperlukan pemberian informasi keadaan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan.

Evakuasi :

1. Tata cara tertulis. Harus memiliki Peta geomedik untuk menentukan jarak dan waktu tempuh menuju lokasi .
2. Kondisi pasien Stabil dan optimal pra dan selama evakuasi hingga tujuan.
3. Kriteria : Fisiologis / Anatomis
4. Mekanisme :
 - a) Tahu Tujuan dan Prinsip rujukan.

- b) ABC stabil,
 - c) Immobilisasi,
 - d) Mekanika mengangkat pasien.
- 5. Sarana-prasarana Evakuasi Minimal :
 - a) Alat / Bahan / Obat Bantuan Hidup Dasar
 - b) Cervical collar / splint
 - c) Short serta Long Spine Board
 - d) Wheeled serta Scoop Stretcher
- 6. Evakuasi :
 - a. Darurat respon time 15-20 menit tiba di lokasi:
 - 1. Lingkungan berbahaya (misal kebakaran).
 - 2. Ancaman jiwa (misal perlu tempat rata dan keras untuk RJP).
 - 3. Prioritas bagi pasien ancaman jiwa
 - b. Segera respon time 20-30 menit tiba di lokasi :
 - 1. Ancaman jiwa, perlu penanganan segera.
 - 2. Pertolongan hanya bisa di RS (misal pernafasan tidak adekuat, syok).
 - 3. Lingkungan memperburuk kondisi pasien (hujan, dingin dll).
 - c. Biasa respon time 30-60 menit tiba di lokasi:
 - Tanpa ancaman jiwa, namun tetap memerlukan RS

F. HAL-HAL YANG DIATUR KHUSUS

- 1. Petunjuk Pelaksanaan Permintaan dan Pengiriman bantuan medik dari RS rujukan.
- 2. Protap pelayanan gawat-darurat di tempat umum.
- 3. Pedoman pelaporan Penilaian Awal/Cepat.

G. Prosedur Khusus

Berikut adalah prosedur pelayanan SiFast secara lebih rinci:

1. Penerimaan Laporan:

Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat medis menghubungi nomor SiFast. Petugas call center akan menerima dan mencatat laporan tersebut.

2. Verifikasi Laporan:

Petugas call center akan melakukan verifikasi informasi yang diberikan, seperti jenis kejadian, lokasi kejadian, dan kondisi pasien.

3. Instruksi Awal:

Petugas call center akan memberikan instruksi awal kepada pelapor, misalnya, terkait pertolongan pertama yang bisa dilakukan sambil menunggu tim medis datang.

4. Pengiriman Tim Medis:

Jika diperlukan, petugas call center akan mengirimkan tim medis (ambulans) ke lokasi kejadian.

5. Penanganan di Lokasi Kejadian:

Tim medis akan memberikan pertolongan pertama, menstabilkan kondisi pasien, dan melakukan evakuasi jika diperlukan.

6. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan:

Setelah kondisi pasien stabil, tim medis akan merujuk pasien ke fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll.) yang sesuai dengan kondisi pasien.

7. Monitoring dan Evaluasi:

Petugas PSC 119 akan terus memantau perkembangan pasien dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan.

Penting untuk diingat bahwa SiFast adalah layanan gratis dalam radius 5 km yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama pada kasus gawat darurat medis sebelum pasien dibawa ke fasilitas kesehatan.

H. SPGDT SEHARI-HARI

- a) *Time Saving is Life Saving*.
- b) *Response Time* sesingkat mungkin.
- c) Merujuk *The Right Patient to The Right Place in The Right Time*

I. GEOMEDIC MAPPING

a. Manfaat :

- a) Keterpaduan konsep penyusunan pelayanan kesehatan dalam bencana
- b) Memudahkan mobilisasi sumberdaya (SDM, logistik medik, ambulans)

b. Tujuan penyusunan map

Tujuan Umum :

Gambaran kekuatan sumberdaya (SDM, sarana-prasarana, fasilitas kesehatan) dan lokasi potensi bencana untuk menunjang SPGDT.

Tujuan Khusus :

- a) Identifikasi kekuatan dalam upaya preparednes
- b) Mengetahui Potensi bencana dan penanggulangannya
- c) Dapat mengambil langkah sesuai potensi yang ada
- d) Pedoman pada gawat darurat bencana

c. Kandungan map :

- a) Resource map : informasi sumber daya
- b) Hazard map : informasi jenis dan karakter hazard
- c) Vulnerability map : distribusi elemen masyarakat yang terancam
- d) Community & environmental map : informasi mengenai komunitas

d. Prinsip mapping :

- a) Potensi ancaman gawat darurat
- b) Bagaimana penanggulangan potensi saat ini dan yad
- c) Simbol seragam agar tidak terjadi miskomunikasi
- d) Didistribusikan dan disosialisasikan
- e) Termasuk sarana transport dan komunikasi
- f) Tentukan koordinator intra dan lintas sektor serta pusat informasi bersama
- g) Tentukan kerjasama di daerah perbatasan
- h) Perbaharui setiap 6 bulan
- i) Perlu komitmen pihak terkait dalam kerjasama lintas sector

J. KOMUNIKASI PPGD :

a. Latar Belakang :

- a) Time saving is life & limb saving
- b) Peningkatan kasus gawat darurat
- c) Perubahan epidemiologi penyakit
- d) Potensi bencana yang tinggi
- e) Kondisi geografis akses sulit di gang sempit dll
- f) Penghubung fase SPGDT (Pra, Intra dan Antar RS)

b. Masalah Pemilihan Perangkat keras Komunikasi :

- 1. Fasilitas tidak memadai/merata dan tidak dijamin bebas gangguan
- 2. Toleransi minimal kasus gawat darurat bila ada hambatan komunikasi

c. Pilihan:

- 1. Utama: Fasilitas telekomunikasi umum
- 2. Cadangan: Radio. Menjadi pilihan utama bila fasilitas telepon tidak ada
- 3. Fasilitas umum gagal
 - Dapat menghubungkan titik pelayanan terendah hingga tertinggi
 - Dapat mengatasi keadaan terburuk dari segi teknis

d. Prosedur Komunikasi Radio:

- 1. Menenal perangkat
- 2. Mampu menyiapkan perangkat
- 3. Pedoman berbicara serta tatacara berkomunikasi

e. Sistem Komunikasi PPGD:

- 1. Jenis jaringan :
Intra sektor sistem tertutup, lintas sektor sistem terbuka, sistem penunjang
- 2. Bentuk jaringan : Intra Tim, lokal, regional, nasional
- 3. Aspek Muatan : Gawat darurat : S/B/KLB; Normal : rujukan program, alat

4. Aspek Teknis : Hardware sesuai, software Network, pelaporan, logbook, kode
5. Pengembangan Teknis : Inter/intranet, teleconference, video-phone
6. Aspek Pengembangan

K. UNIT PENDUKUNG DALAM RANGKA TERBENTUKNYA COMMAND CENTER RS

a. PRA RUMAH SAKIT

1. Unit mobil ambulance emergensi (untuk penanganan BTLS, BTCLS, ACLS) 1 dokter, 1 dokter spesialis, 1 psikolog, 1 psikiater, 1 perawat umum, 1 perawat bedah, 1 bidan semuanya harus berkompeten di bidang nya masing – masing.
2. Koordinasi dengan jaringan RS trauma center yang ada
3. Korrdinasi dengan polsek dan polres (Polantas) setempat
4. Koordinasi dengan Relawan dan BPBD setempat

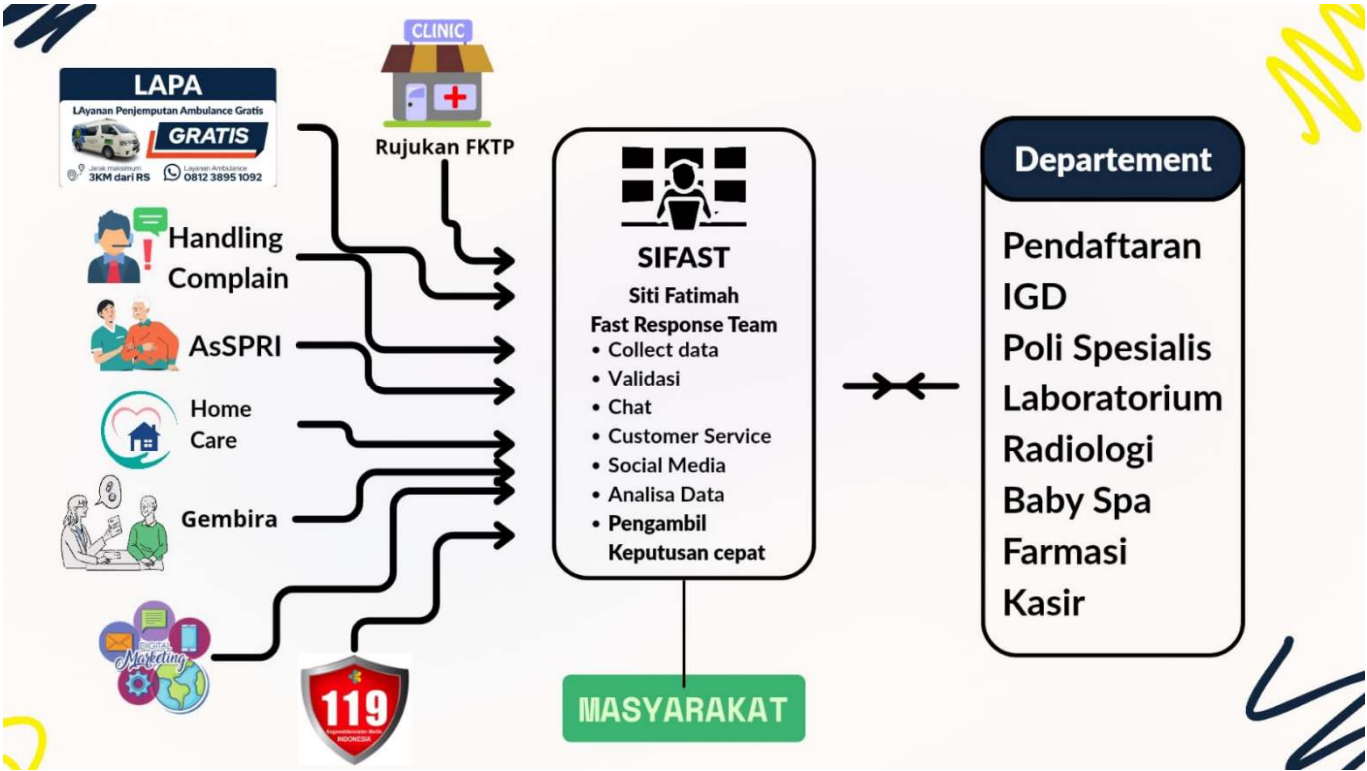
b. INTRA RUMAH SAKIT (IGD)

1. Ruang triase yang memadai dan penilaian triase di lakukan sesuai SPO
2. Tenaga medis dan tenaga paramedic yang memadai
3. Ruang bedah mayor/ minor yang memadai dan siap 24 jam
4. Ruang perawatan ICU yang memadai dan siap 24 jam
5. Ruang laboratorium yang memadai dan siap 24 jam
6. Instalai farmasi yang memadai dan siap 24 jam

c. REHABILITASI MEDIK

1. Ruang fisioterasi dan rehabilitasi fisik
2. Ruang perawatan rawat inap yang mempunyai fasilitas setingkat IGD atau ICU
3. Ruang rehabilitasi jiwa/mental dan perilaku
4. Pelayanan antar pasien kembali ke rumah post perawatan (pelayanan plus) gratis

ALUR PELAYANAN *Siti Fatimah Fast Response Team (Si-FAST)*



Lampiran pendukung :

Petunjuk Pengisian Registrasi Online Jejaring Faskes :

Nomor dan tanggal registrasi by sistem

1. NAMA JEJARING FASKES

Diisi dengan nama Faskes kabupaten/Kota sesuai Surat Keputusan

2. ALAMAT

Diisi sesuai alamat

- a. Jalan : (cukup jelas)
- b. Provinsi : pilihan provinsi
- c. Kabupaten/kota : pilihan kabupaten/kota
- d. Nomor telp lokal : (cukup jelas)
- e. Nomor Faksimile : (cukup jelas)
- f. Website : (cukup jelas)
- g. Alamat email : (cukup jelas)
- h. Media sosial dan Grup

Sebutkan, misal facebook, instagram, telegram, whatsapp dll

3.PIMPINAN JEJARING

Diisi dengan nama pimpinan dan gelar jika ada

4. Nomor Kontak JEJARING

Diisi dengan nomor HP

5. NOMOR SK PEMBENTUKAN JEJARING

Diisi dengan nomor SK yang tercantum

6. TANGGAL PEMBENTUKAN JEJARING

Diisi dengan tanggal pembentukan dalam SK

8. TENAGA JEJARING

a. KOORDINATOR

disebutkan jumlahnya (orang)

b. PETUGAS KESEHATAN

diisi dengan :

1. jumlah dokter,
2. jumlah perawat,
3. jumlah bidan dan lain-lain jika ada misal SKM atau

c. Petuas Pendukung

(IT dan Operator atau pendukung lainnya) disebutkan jumlahnya (orang)

d. Sopir ambulans

disebutkan jumlah orangnya

9. PELAPORAN

1. JUMLAH PANGILAN YANG MASUK
2. JUMLAH PANGGILAN YANG JAWAB PETUGAS
3. JUMLAH PANGGILAN YANG PERLU TINDAKAN
4. JUMLAH PANGGILAN YANG PERLU RUJUKAN KE FASYANKES

10. PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI JEJARING

1. PUSKESMAS
2. RUMAH SAKIT
3. BPM
4. Praktik Mandiri
5. Ormas
6. Pribadi/perorangan